

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22232865106 | 346

DURVAL DE ABRAHÃO

IDADE: 46 PESO: 74 ALTURA: 172 PROFISSÃO: militar

SINTOMAS:

QUEIXAS: Ronca

MEDICAMENTOS:

HBP (hipertensão benigna) / Menigioma Benigno / HANS

MÉDICO: Drº Alexandre Coelho

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhada 4-5km

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 6:10

COCHILLO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () NÃO NA SEMANA () NÃO Vinho / cerveja (zero)

FUMO () SIM () NÃO / DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 3 a 4x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: III IAH: 43.6 / ev SPO2: 76%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinite

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA 2021 Retirou o menin
guêna.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

24/05 Avaliação - D máx. N30i
24

03/06 P = 7.8 med.

24 IAH = 0.8 e lev

M. de uso: 6h30'

boa.

14/06 P = 8.3 med.

24 IAH = 0.7 e lev

M. de uso: 6h30'

ajuste pl pressão fixa

boa

24/06 P = 7.8 cmH₂O

24 IAH = 0.7 e lev

M. de uso: 6h

Comprou o CPAP

boa

02/08 P = 7.8 cmH₂O

24 IAH = 0.6 e lev

M. de uso: 26.4 lpm

Bem adaptado.

1x ao banheiro

boa

04/09 P = 7.8 cmH₂O

24 IAH = 0.4 e lev

M. de uso: 6h5'

fluxo: 29.6 lpm

Bem adaptado

boa

Natasha

Teve consulta no dia 19/09/24.

06/11/24 $P = 7.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.3 \text{ e/h}$
m. de uso: 5 h 24'
fuga: 32.8 lpm

Bem adaptado

Natacha

17/01/25 $P = 7.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 5 h 10'
 $IAH = 0.2 \text{ a/h}$
Fuga = 35.2 lpm.

20/02
25 $P = 7.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.3 \text{ e/h}$
M. de uso: 4 h 35'
fuga = 27.8 lpm.

boa claudia

Boca seca e está relatando

70% ↑ 4 m

30 ↓ 4 h

19/05
25 $P = 7.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 0.4$
Fuga = 20.2 lpm.
m. de uso: 6 h 11'

30d → 4 h

boa

16/06/25 $\downarrow$ umidif 05 queixa bafejo groncho no tubo

silva



Clínica
DR. ALBERTO REMESAR
Psiquiatria do bem-estar

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Durval de Abrahão

EXAME nº: 5593

SOLICITADO POR: Dr. Alexandre Coelho Marques

DATA 12/04/2024

IDADE: 76 anos

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria pela UFRJ
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono
CRM 69.730 - RQE 40.178

Comentários:

Exame iniciado às 23h23min e concluído às 06h08min. A latência para o sono foi de 3 minutos e a latência para o estágio REM, de 81 minutos. O tempo total de sono foi de 319 minutos (05h19min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 80,8%. A distribuição do sono mostrou 14,9% de estágio 1, 43,1% de estágio 2, 24,1% de estágio 3 e 17,9% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 72,5 minutos em vigília, ocorreram 106 microdespertares (índice: 19,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 1,3/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 43,6/hora, sendo 16,6 apneia/hora e 27,1 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 43,8/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 76%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (43,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (43,8/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, despertares e arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 46; máxima: 65 bpm.

O ronco foi contínuo e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 3 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava normal (81 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 80,8%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 19,9/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (14,9%; normal: 8-10%) e 3 (24,1%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (43,1%; normal: 45-55%) e REM (17,9%; normal: 20%).

O índice de movimentos periódicos de membros (1,3/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 8 (normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474, sl 51 e 52
Ed. Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 | (12) 3941-2449 | (12) 99622-8008

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730